[redacted]
SALUD PÚBLICA PARA PSICÓLOGOS

EJE 02 · PSICOLOGÍA

Cuidado Integral de Salud

Evaluación e intervención psicológica dentro del curso de vida y las prioridades sanitarias.



02	29	7.ª
EJE OFICIAL	TEMAS DESARROLLADOS	EDICIÓN · OCT. 2026

Contenido y diseño [redacted]

[redacted] conservan sus licencias

EJE 02 · MAPA DE ESTUDIO

Tu ruta por el eje

Evaluación e intervención psicológica dentro del curso de vida y las prioridades sanitarias.

01

Competencias específicas de Psicología

El cuidado psicológico integra evaluación rigurosa, intervención basada en evidencia, seguridad, derechos y articulación con la red.

7 TEMAS

02

Aten a

Los paqu cción, tratamiento, rehabilita

9 TEMAS

03

Prioridades sanitarias transversales

La Psicología contribuye a prevención, adherencia, afrontamiento, detección de riesgo y continuidad en múltiples estrategias sanitarias.

13 TEMAS

RUTA DE USO

01 **COMPRENDE**
Relaciona ideas

02 **RECUPERA**
Explícalo sin mirar

03 **PRACTICA**
Corrige tus errores

conservan sus licencias

01

Competencias específicas de Psicología

El cuidado psicológico integra evaluación rigurosa, intervención basada en evidencia, seguridad, derechos y articulación con la red.

EN ESTE RECORRIDO

01 **Evaluación psicológica** **ción y examen mental**

03 **Atención y continuidad e** **das en evidencia**

05 **Problemas prioritarios de sa** **ación clínica**

07 **Aspectos legales de la atención psicológica**

OBJETIVO DEL CAPÍTULO

Revisa la ruta, explica cada tema con tus palabras y después practica con casos.

conservan sus licencias

TEMA 01 · EJE 02

Evaluación psicológica

Evaluar no es aplicar pruebas de forma aislada. Es un proceso de formulación y toma de decisiones que parte de una pregunta clara. A partir de ella se eligen las técnicas y se contrastan datos de entrevista, observación, pruebas y otras fuentes. La conclusión explica coincidencias, discrepancias y límites. Un test aporta evidencia, pero no reemplaza el juicio profesional ni determina por sí solo un diagnóstico.

CONCEPTOS QUE SOSTIENEN EL TEMA

Evaluación
Proceso de recoger, integrar e interpretar información para responder una pregunta y tomar decisiones.

Técnica
Procedimiento para obtener información, como entrevista, observación o aplicación de una prueba.

Hipótesis
Explicación provisional que se

EVALUAR ES INTEG S

01	Delimitar Motivo, context
02	Recoger Entrevista, observa
03	Integrar Contrastar datos, límites y alternativas · Formulación y conclusiones
04	Devolver Explicar hallazgos y acordar recomendaciones · Plan comprensible y útil

conservan sus licencias

ANCLAS PARA RECORDAR

01	Definir motivo, pregunta de evaluación e hipótesis antes de elegir instrumentos.
02	Seleccionar pruebas válidas, confiables, pertinentes y autorizadas para población y propósito.
03	Integrar resultados con juicio clínico y fuentes múltiples.
04	Devolver hallazgos con lenguaje claro, límites y recomendaciones.

CLAVE DE EXAMEN **Un puntaje aislado no basta para diagnosticar ni decidir una intervención.**

Fuente: Temario oficial MINSA para Psicología y bibliografía institucional vinculada.

conservan sus licencias

TEMA 02 · EJE 02

Entrevista, observación y examen mental

La entrevista construye alianza y recoge información; la observación contrasta conducta y contexto; el examen mental describe el estado actual.

DOMINIOS DEL EXAMEN MENTAL

Dominio	Qué observar	No confundir
Apariencia y conducta	Presentación, actividad y contacto	Descripción con juicio moral
Ánimo y afecto	Experiencia referida y expresión observada	Ánimo con afecto
Pensamiento y percepción	Cu ex	con hecho
Cognición, juicio e insight	Or co	con diagnóstico

ANCLAS PARA REC

01
Explorar apariencia, condu iolencia, vulnerabilidad, orientación, atención, leng pensamiento, percepción, co insight.

03
Diferenciar relato, observación e inferencia en el registro.

CLAVE DE EXAMEN **El examen mental es descriptivo y transversal; la historia clínica aporta evolución y contexto.**

Fuente: Temario oficial MINSA para Psicología y bibliografía institucional vinculada.

conservan sus licencias

Examen mental: describir antes de interpretar

La descripción clínica se apoya en entrevista, observación y evolución. Los siguientes ejemplos son didácticos y no establecen diagnósticos.

Contraste	Ejemplo y pista
Ánimo / afecto	«Me siento triste» es ánimo referido; llanto, rango y reactividad se describen como afecto observado. Pueden coincidir o diferir.
Curso / contenido del pensamiento	La velocidad, continuidad y organización pertenecen al curso; las ideas, preocupaciones o creencias, al contenido.
Ilusión / alucinación	En una ilusión se interpreta erróneamente un estímulo existente; en una alucinación la experiencia perceptiva ocurre sin el estímulo externo correspondiente. Explorar contexto.
Atención / memoria	No registrar «memoria alterada» sin comprobar que la persona pudo atender y
Juicio / conciencia del problema	ión de la situación; discrepar con el

REGISTRO ÚTIL

Hecho referido: «no dormí en durante la entrevista.
Hipótesis: considerar causas d s los tres niveles.

La aparición brusca de desorient alorar una causa médica. No atribuirla de entrada a un proble tras se retrasa la atención necesaria.

Fuentes: [N10], [N11].

conservan sus licencias

TEMA 03 · EJE 02

Atención y continuidad en salud mental

El plan de cuidado se construye con la persona, objetivos funcionales, intervenciones, responsables, seguimiento y criterios de referencia.

Continuidad de cuidados: tres componentes

- Clínico: atiende salud mental y física, síntomas y necesidades de la persona y de su cuidador.
- Psicosocial: favorece vínculos, funcionamiento familiar, laboral y comunitario.
- Gestión: coordina recursos, citas, responsabilidades y acceso oportuno.

El Programa de Continuidad de Cuidados integra estos componentes mediante un plan individualizado y participación activa de la persona; no se reduce a comprobar que tome medicamentos.

Fuentes: [R021] MINSA. Guía técnica de continuidad de cuidados. RM 663-2023/MINSA, publicada 14-07-2023; edición 2024

Cuidado, recuperaci

El cuidado de la salud mental i ón y acompañamiento. La recuperación comprende el tra n busca mejorar funcionamiento e inclusión. La Ninguna de estas categorías elimina la obligació o o violencia activa.

Fuentes: [R022] MINSA. Plan nacional de f RM 356-2018/MINSA · [R023] MINSA. Guía técnica de salud mental de mujeres e 26-05-2021

ANCLAS PARA RECOR

01	Priorizar seguridad, necesidades urgentes y preferencias informadas.
02	Coordinar primer nivel, CSMC, hospital, familia y actores comunitarios.
03	Registrar adherencia, respuesta, eventos adversos y barreras.
04	Planificar alta y señales de alarma desde el inicio.

CLAVE DE EXAMEN **Continuidad significa que la ruta no se corta entre servicios ni niveles.**

Fuente: Temario oficial MINSA para Psicología y bibliografía institucional vinculada.

conservan sus licencias

TEMA 04 · EJE 02

Psicoterapias basadas en evidencia

La elección considera problema, evidencia, severidad, comorbilidad, preferencias, cultura, recursos y competencia profesional.

Dos modelos ABC que debes diferenciar

Concepto	Cómo reconocerlo	No confundir
Análisis funcional	A: antecedentes; B: conducta; C: consecuencias. Formula una hipótesis sobre qué mantiene el problema.	El registro describe; el análisis relaciona variables y función.
Ejemplo	An es su ref	ediato no implica que el e haya resuelto.
ABC de Ellis	A: int e	no significa conducta. Se s rígidas y alternativas

Fuentes de esta ampliación: [E] MINSA · C elo ABC

conservan sus licencias

Reconocer técnicas en un caso

Concepto	Cómo reconocerlo	No confundir
Activación conductual	Planificar actividades significativas y observar cómo se relacionan con ánimo, evitación y refuerzo.	No es recomendar estar ocupado sin objetivos ni seguimiento.
Reestructuración cognitiva	Identificar una interpretación, examinar evidencias y formular una alternativa que pueda ponerse a prueba.	No equivale a imponer pensamiento positivo.
Exposición	Acercamiento planificado a situaciones temidas y seguras; reducir evitación y conductas de seguridad.	Se individualiza; no se fuerza una situación realmente peligrosa.
Desensibilización sistemática	Formato clásico que combina jerarquía de estímulos y respuesta de	No toda exposición exige relajación ni se llama desensibilización.
Refuerzo / extinción	Re su de m	egativo retira algo aversivo; no es e castigo.
Sobrecorrección	En ex pr re	no no autoriza nitivos, humillantes o s.
Respiración y relajación	La relaja Jacob activ integrarse en intervenciones cognitivo-conductuales.	sí solas un enfoque ican gradualmente y se tan el malestar; en trauma evaluación ni los tratamientos específicos.
Enfoque sistémico	Explorar pautas de interacción, roles, límites y respuestas recíprocas dentro de la familia.	No reducirlo a buscar un culpable individual ni suponer que siempre exige reunir a toda la familia.

Fuentes de esta ampliación: [M] OMS · Guía mhGAP, tercera edición, 2023 · [E] MINSA · Cuadernillo oficial Psicología 2026-II · [EXP] APA · What is exposure therapy? · [OC] Investigación histórica · Sobrecorrección · [R008] US Department of Veterans Affairs, National Center for PTSD. Alternative Treatments · [R009] US Department of Veterans Affairs. Coping with Traumatic Stress Reactions · [R010] US Military Health System. Stress Reduction Techniques for High Stress Operations

conservan sus licencias

ANCLAS PARA RECORDAR

01	Intervenciones estructuradas definen objetivos, técnicas y seguimiento de resultados.
02	La alianza terapéutica y la formulación orientan la aplicación, no un protocolo rígido.
03	Monitorear síntomas, funcionamiento y riesgo permite ajustar el plan.
04	Derivar o supervisar cuando el caso excede competencia o recursos.

CLAVE DE EXAMEN **Basada en evidencia = mejor investigación disponible + experiencia clínica + valores de la persona.**

Fuente: Temario oficial MINSA para Psicología y bibliografía institucional vinculada.

conservan sus licencias

Dos modelos ABC

Las mismas letras representan componentes diferentes.

Una situación, dos lecturas. En una reunión se le pide a una persona que presente un caso. Solicita que otra persona lo exponga por ella.

ABC funcional · ¿qué ocurre antes y después?

A

Antecedente

Se le pide presentar el caso ante el equipo.

→

B

Conducta

→

C

Consecuencia

El colega expone y la demanda de presentar se retira.

Hipótesis a comprobar: si el patrón

itación. Un episodio por sí solo no

demuestra esa función.

ABC de Ellis · ¿cómo inter

A

Acontecimiento

Se le pide presentar el caso ante el equipo.

→

B

Creencias

"Debo hacerlo perfecto; equivocarme demostraría que soy incapaz".

→

C

Consecuencias

Ansiedad y evitación de la presentación.

El esquema de Ellis relaciona acontecimiento, creencias y respuesta emocional/conductual; no implica que todo malestar dependa únicamente de lo que se piensa.

REPASO ACTIVO

En el ABC funcional, ¿la B significa creencia?

No. B = conducta (behavior). En el modelo de Ellis, B = creencias (beliefs).

IRIS Center · Registro ABC; Albert Ellis Institute · Emotional Disturbance and Its Treatment, pp. 1-2.

conservan sus licencias

TEMA 05 · EJE 02

Problemas prioritarios de salud mental

La prioridad clínica depende primero de la seguridad y la funcionalidad, no solo del nombre del trastorno. Ante violencia, riesgo suicida, psicosis aguda o intoxicación se evalúan peligro inmediato, capacidad de autocuidado, soporte y necesidad de atención urgente. Después se completa la evaluación diagnóstica y se organiza una ruta continua, documentada y coordinada con la red.

Elegir el tamizaje

• PHQ-9: nueve preguntas sobre síntomas depresivos de las últimas dos semanas; ayuda al tamizaje y seguimiento de intensidad.

• GDS-15 o Yesavage abreviada: quince preguntas para explorar depresión en personas adultas mayores.

• SRQ: pesquisa malestar y po versión, población y punto de corte validado.

• M-CHAT-R/F: probabilidad d

Los instrumentos no son interc La evaluación del riesgo suicida requiere preguntas clín

Fuentes: [R003] MINSA. Guía de práctica cl yores de 18 años. RM 136-2023/MINSA, 10-02-2023 · [R004] MI

PRIMERO SEGURID

Situación	Valor	
Riesgo suicida	Ideación, plan, medios, intentos y protección	No dejar sola a la persona; activar ruta
Violencia	Seguridad actual, lesiones, menores y red	Escuchar, proteger, registrar y coordinar
Psicosis aguda	Riesgo, agitación, autocuidado, sustancias y causa médica	Ambiente seguro y evaluación urgente
Consumo problemático	Intoxicación, abstinencia, daño y motivación	Reducción de daño y referencia según severidad

conservan sus licencias

Señales orientadoras, no diagnósticos aislados

Concepto	Cómo reconocerlo	No confundir
Depresión	Ánimo deprimido o pérdida de interés, con cambios cognitivos, físicos y funcionales sostenidos.	Explorar riesgo suicida, duración, episodios de exaltación y posibles causas médicas o sustancias.
Ansiedad	Miedo o preocupación excesivos, activación física y evitación que generan malestar o deterioro.	Distinguir desencadenante, persistencia, pánico y condiciones médicas.
Psicosis	Delirios, alucinaciones o desorganización, según el cuadro clínico.	No diagnosticar esquizofrenia por un síntoma; valorar sustancias, delirium, curso y seguridad.
TEA	Dificultades persistentes de comunicación e interacción social junto con patrones restringidos o repetitivos.	La valoración integra desarrollo, contexto y necesidades; no depende de un único gesto o test.
TDAH	In sueño insuficiente, ansiedad, hi s de aprendizaje y condiciones pe s. en	

Depresión leve: pri

Tras valorar gravedad, funcion icas o por sustancias, el manejo inicial de la depresión trategias psicológicas breves, con seguimiento acord poner objetivos alcanzables. La intensidad y du mizaje aislado no determina tratamiento ni un n

Fuentes: [R003] MINSA. Guía de práctica clínic yores de 18 años. RM 136-2023/MINSA, 10-02-2023

Clasificación orientadora

El TDAH y el trastorno del espectro autista pertenecen a los trastornos del neurodesarrollo. La clasificación no reemplaza la valoración del desarrollo, del funcionamiento y del contexto.

Fuentes: [R005] OMS. Mental disorders

Fuentes de esta ampliación: [D] OMS · Mental disorders

conservan sus licencias

ANCLAS PARA RECORDAR

01	Suicidio: preguntar de forma directa no induce la conducta; valorar ideación, plan, medios, intentos y protección.
02	Psicosis: descartar emergencia médica o sustancias y valorar riesgo, autocuidado y soporte.
03	Violencia: seguridad, escucha sin culpabilizar, registro y ruta legal/sanitaria.
04	TEA/TDAH: evaluación evolutiva y funcional; evitar diagnósticos por un único cuestionario.
05	Consumo: AUDIT-C permite tamizaje breve de alcohol y ASSIST explora alcohol, tabaco y otras sustancias; un resultado positivo orienta evaluación e intervención, no establece por sí solo un diagnóstico.
06	La intervención motivacional explora ambivalencia, razones propias para cambiar y autoeficacia sin confrontación; la referencia depende de severidad, riesgo y capacidad resolutiva.
07	En intoxicación al cia, ventilación, signos vitales, trauma, comorbili a.
08	El PAI organiza in ida. El PCCI añade coordinación y se ental grave o un riesgo psicosocial que e de riesgo para diferenciarlos.

CLAVE DE EXAMEN **Ant n urgente preceden a la psic**

Fuente: Temario oficial MINSA para Psicología y bibliografía institucional vinculada.

conservan sus licencias

Triaje: cinco prioridades

Escala de prioridades para el repaso · Actualización de 2026

Clasificar la urgencia permite ordenar el inicio de la atención. Los tiempos se cuentan desde la clasificación de prioridad en triaje.

I

Emergencia de gravedad súbita extrema — INMEDIATA

Riesgo inminente de muerte o deterioro funcional severo. Unidad de Shock Trauma y Reanimación.

II

Emergencia — Hasta 10 min

Amenaza potencia uy intenso.

III

Urgencia — Hasta 30 min

Sin riesgo potenci

IV

Urgencia menor — Hasta 60 min

Sin compromiso del estado general ni riesgo evidente para la vida o la función.

V

No urgencia — Hasta 120 min

Problema agudo o crónico no urgente. Atención en consulta externa o quien haga sus veces.

Nota editorial: los colores de esta lámina son un recurso didáctico de : no representan una codificación cromática prescrita por la resolución. Esta escala no reemplaza la evaluación clínica.

Fuente: RM 625-2026-MINSA, artículo 6 (pp. 5-6 del PDF), modificación de la NTS 042 sobre servicios de emergencia.

conservan sus licencias

Riesgo suicida: de la pregunta directa a una acción concreta

La evaluación es clínica y dinámica. Ningún puntaje ni una etiqueta de «riesgo bajo» sustituye la valoración de seguridad.

Explorar	Para decidir
Situación actual	Ideación, intención, plan, acceso a medios, actos preparatorios e intento reciente.
Contexto	Agitación, intoxicación, psicosis, dolor, pérdidas, violencia y cambios recientes.
Antecedentes y apoyos	Intentos previos, atención recibida, personas de apoyo y posibilidades reales de acompañamiento.
Capacidad de seguridad	Si puede colaborar con un plan, acceder a ayuda y mantenerse protegido en su entorno.

Ante peligro inmediato, protege coordinar atención urgente en la red. La psicoterapia programada ión necesaria con quienes intervienen en protección y aten

PLAN DE SEGURIDAD

Acordar señales personales de s elegidos, acceso a atención y reducción segura d se verificará el seguimiento.

Un compromiso verbal de «no h bios clínicos, alta, pérdida de apoyo o nuevas crisis. Documentar nes; no solo una categoría de riesgo.

Fuentes: [N10].

conservan sus licencias

TEMA 06 · EJE 02

Rapport y comunicación clínica

El rapport es una relación de confianza, respeto y colaboración que facilita información válida y adherencia.

Privacidad y comunicación no verbal

Una entrevista requiere privacidad visual y acústica: un biombo en una sala compartida puede ocultar a la persona, pero no impedir que otros escuchen. Buscar un ambiente confidencial y explicar cualquier limitación. Gestos, tono y postura también comunican; mostrar asco o rechazo ante prácticas culturales deteriora la confianza. Explorar su significado con respeto, sin renunciar a explicar riesgos para la salud.

Fuentes: [R006] Reglamento de la Ley 29414. DS 027-2015-SA, 13-08-2015 · [R007] MINSA. NTS 201-MINSA/DGIESP-2023, estándares de calidad para establecimientos que brindan cuidado integral de adolescentes. RM 356-2023/MINSA, 03-04-2023

ANCLAS PARA REC

01	Escucha activa, pr
02	Evitar juicios, tecn ria.
03	Adaptar comunic
04	Explicar confiden

CLAVE DE EXAMEN **Valida ucta o interpretación.**

Fuente: Temario oficial MINSA para Psicología y bibliografía institucional vinculada.

conservan sus licencias

TEMA 07 · EJE 02

Aspectos legales de la atención psicológica

La práctica exige consentimiento informado, confidencialidad, historia clínica, protección de datos, competencia y actuación ante riesgos o mandatos legales.

CUATRO OBLIGACIONES QUE SE RELACIONAN

Obligación	Exige	Límite o condición
Consentimiento	Información, comprensión y voluntariedad	Excepciones previstas por ley
Confidencialidad	Pr	ve o mandato legal justificado
Competencia	Ac fu	o derivar si se excede
Registro	Tr	ner datos innecesarios

Violencia: atención

Concepto	Có	
Primera atención	Valor urge culpabilizar ni exigir un relato reiterado innecesario.	ud no debe transformarse robatorio.
Articulación	Coordinar con el CEM y servicios competentes conforme a la ruta y a las obligaciones aplicables; registrar actuaciones.	No prometer secreto absoluto cuando existen deberes de comunicación o protección.
Continuidad	Facilitar comprensión de opciones, seguimiento y acceso seguro; limitar circulación de información a lo necesario.	Derivar no equivale a abandonar el acompañamiento ni compartir indiscriminadamente el expediente.

conservan sus licencias

AVISAS: seis dimensiones del cuidado

Ante violencia sexual, AVISAS organiza la respuesta:

- Acogida y ayuda durante la crisis.
- Valoración emocional, física y sexual.
- Intervención clínica según necesidades.
- Seguimiento del caso.
- Acceso a información y justicia.
- Seguridad mediante un plan de protección.

Se articulan sin culpar, interrogar repetidamente ni condicionar la atención a una denuncia previa.

Fuentes: [R024] MINSA. NTS 164-MINSA/2020/DGIESP, RM 649-2020/MINSA, 20-08-2020

Violencia sexual reciente: atención urgente

Valorar lesiones, embarazo, exposición a ITS/VIH, estado emocional y seguridad. Explicar cada procedimiento y obtener el consentimiento correspondiente; aceptar una intervención no obliga a aceptar todas. El kit se indica según ex clínica. Si corresponde profilaxis posexposición al VIH, iniciarla ar también anticoncepción de emergencia y otras medidas in s, pruebas pendientes o negativa a denunciar personalmente.

Fuentes: [R025] MINSA. NTS 164, texto ap ost-exposure prophylaxis, 22-07-2024

Atención, denuncia ntas

Si una mujer adulta rechaza pr la atención y se explican los límites legales de confiden echos de violencia conocidos en su función confo o o Poder Judicial. Coordinar apoyo del CEM y conti mpartir solo información necesaria y valorar riesgos para l

Fuentes: [R027] Reglamento de la Ley 30364, art. 15.1, modificado por DS 004-2019-MIMP, 07-03-2019 · [R024] MINSA. NTS 164-MINSA/2020/DGIESP, RM 649-2020/MINSA, 20-08-2020

Gestación en menor de 14 años

La gestación de una niña menor de 14 años exige activar atención por violencia sexual y protección, aunque el relato describa una relación «consentida». Evaluar seguridad, lesiones, salud mental y riesgo obstétrico; una gestación avanzada requiere atención obstétrica oportuna, sin esperar trámites legales. Comunicar a las autoridades competentes y coordinar la protección y continuidad del cuidado, evitando revictimización.

Fuentes: [R028] Código Penal, art. 173, redacción de la Ley 30838, publicada 04-08-2018; texto citado por el Tribunal Constitucional en 2026 · [R024] MINSA. NTS 164-MINSA/2020/DGIESP, RM 649-2020/MINSA, 20-08-2020 · [R018] MIMP. Lineamientos de coordinación CEM-UPE-DEMUNA. RM 237-2024-MIMP, 13-07-2024

conservan sus licencias

Violencia de pareja: riesgo y capacidad de respuesta

Un nivel bajo de riesgo no significa ausencia de violencia ni equivale automáticamente a daño mental leve. El primer nivel puede brindar el cuidado que corresponda a su capacidad, con plan de seguridad y seguimiento. Derivar según peligro, gravedad, necesidades obstétricas, complejidad clínica o recursos insuficientes; no enviar todos los casos al CSMC de forma automática.

Fuentes: [R023] MINSA. Guía técnica de salud mental de mujeres en situación de violencia por pareja o expareja. RM 670-2021/MINSA, 26-05-2021

Fuentes de esta ampliación: [VIO] MIMP · Protocolo de actuación conjunta CEM y establecimientos de salud

ANCLAS PARA RECORDAR

01
Consentimiento es un proceso voluntario, informado y comprensible; no solo una firma.

02
Asentimiento del menor se integra con autorización correspondiente, salvo excepciones legales.

03
Compartir solo informació
canal seguro.

04
uación, decisiones,
ndamento.

CLAVE DE EXAMEN **La c**
expl
y seguridad; deben

Fuente: Temario oficial MINSA para Psicol

conservan sus licencias

02

Atención integral por curso de vida

Los paquetes de cuidado combinan promoción, prevención, detección, tratamiento, rehabilitación y seguimiento según etapa vital.

EN ESTE RECORRIDO

08 **Atención Primaria de Sal** **o integral por curso de vida**

10 **Gestante y periodo prena**

12 **Adolescente**

14 **Persona adulta**

15 **Persona adulta mayor**

16 **VACAM: breve, corta y completa**

OBJETIVO DEL CAPÍTULO

Revisa la ruta, explica cada tema con tus palabras y después practica con casos.

conservan sus licencias

TEMA 08 · EJE 02

Atención Primaria de Salud

La APS es una estrategia del sistema basada en primer contacto, integralidad, continuidad, coordinación, orientación familiar y comunitaria.

CONCEPTOS QUE SOSTIENEN EL TEMA

APS
Estrategia que organiza el sistema cerca de las personas, con primer contacto, integralidad, continuidad y coordinación.

Primer nivel
Puerta de entrada habitual que resuelve necesidades frecuentes y articula la atención con otros niveles.

Continuidad
Seguimiento de la persona a lo
incluso cuando intervienen dis

Universalidad
corresponde a todas las personas,
des. Se concreta mediante acceso
n sobre los determinantes sociales;
ntar personas aseguradas

APS NO ES SINÓNI

Concepto	Qu	
APS	Es	tegralidad, continuidad y
Primer nivel	Nivel población	y resolución frecuente
Atención primaria	Prestaciones iniciales y esenciales	Puede describir práctica o nivel operativo

ANCLAS PARA RECORDAR

01	Primer nivel resuelve lo frecuente y articula la red.
02	Participación, intersectorialidad y equidad son componentes centrales.
03	No equivale a atención simple ni exclusiva de establecimientos pequeños.

CLAVE DE EXAMEN **APS es estrategia de organización; primer nivel es parte de la estructura asistencial.**

Fuente: Temario oficial MINSA para Psicología y bibliografía institucional vinculada.

Fuentes: [R011] MINSA. Modelo de Cuidado Integral de Salud por Curso de Vida. RM 030-2020/MINSA, 27-01-2020

conservan sus licencias

TEMA 09 · EJE 02

Modelo de cuidado integral por curso de vida

El curso de vida ayuda a entender cómo una experiencia temprana puede influir en etapas posteriores. Considera periodos sensibles, transiciones y la acumulación de riesgos o factores protectores. En el MCI peruano, el cuidado se organiza en periodo prenatal, niña y niño, adolescente, joven, persona adulta y persona adulta mayor. En cada etapa se combinan acciones con la persona, la familia y la comunidad.

CONCEPTOS QUE SOSTIENEN EL TEMA

Curso de vida
Enfoque que estudia cómo las
experiencias desde antes del n
salud posterior.
de desarrollo de la persona o la
siciones, mientras el curso de vida
cias acumuladas.

Periodo crítico
Ventana limitada en la que un
producir cambios duraderos o
r respuesta o
ión, aunque el cambio
.

Trayectoria
Dirección que sigue una caract
largo del tiempo según riesgos, p
transiciones.
ables o adversas cuyos
ompensarse o interactuar.

conservan sus licencias

EDADES OFICIALES Y FOCO DEL CUIDADO POR CURSO DE VIDA

01	Prenatal Preconcepción, gestación y nacimiento · Desarrollo fetal, cuidado materno, soporte y riesgos tempranos
02	Niña y niño 0 a 11 años, 11 meses y 29 días · Crecimiento, desarrollo, apego, nutrición y protección
03	Adolescente 12 a 17 años, 11 meses y 29 días · Autonomía progresiva, salud mental, sexualidad y proyecto
04	Joven 18 a 29 años, 11 meses y 29 días · Autonomía, estudios/trabajo, vínculos, sexualidad y prevención
05	Persona adulta 30 a 59 años, 11 , familia, adherencia y funcionamiento
06	Persona adulta 60 años a más · orte

POR QUÉ UNA ETAP

Mecanismo	Qu	
Periodo crítico	Vent ollo durante la gestación pued	
Periodo sensible	Etapa de mayor plasticidad, aunque el cambio sigue siendo posible	Lenguaje, apego y regulación emocional
Trayectoria	Dirección que sigue la salud a lo largo del tiempo	Riesgo cardiometabólico que aumenta progresivamente
Acumulación	Exposiciones protectoras o adversas se suman	Pobreza, violencia, estrés y menor acceso
Cadena de riesgo	Una exposición aumenta la probabilidad de otra posterior	Sobrepeso infantil, menor actividad y enfermedad crónica

conservan sus licencias

Cuatro componentes del MCI

- Prestación o provisión: cuidados dirigidos a la persona, familia y comunidad.
- Organización: ordena servicios, equipos y articulación territorial.
- Gestión: planifica, conduce y evalúa los recursos y procesos.
- Financiamiento: sostiene económicamente el cuidado.

Actúan de forma interrelacionada; no son cuatro etapas sucesivas de una consulta.

Fuentes: [R011] MINSA. Modelo de Cuidado Integral de Salud por Curso de Vida. RM 030-2020/MINSA, 27-01-2020

Familia como unidad de intervención

Cuando el equipo acuerda acciones con integrantes del hogar y aborda conjuntamente sus necesidades y relaciones, la familia es unidad de intervención. No se limita a sumar consultas individuales ni a clasificar riesgos: se construye y sigue un plan familiar.

Fuentes: [R012] MINSA. Manual de implementación del MCI. RM 220-2021/MINSA, 12-02-2021, publicada 15-02-2021

ANCLAS PARA REC

01	Combina necesid	es poblacionales.
02	El paquete integr	ntexto.
03	Etapas MINSA: pr mayor.	lta; persona adulta
04	La referencia deb	eferencia.

CLAVE DE EXAMEN **Curso uladas, no etapas aisladas.**

Fuente: Temario oficial MINSA para Psicología y bibliografía institucional vinculada.

conservan sus licencias

TEMA 10 · EJE 02

Gestante y periodo prenatal

El periodo prenatal comprende los cuidados preconcepcionales, la gestación y la preparación para el nacimiento. Incluye salud mental perinatal, violencia, consumo, soporte y coordinación obstétrica.

Objetivo del cuidado prenatal

El cuidado prenatal favorece condiciones para el desarrollo psicomotor, emocional y social. El apoyo a la gestante, la relajación y el vínculo familiar pueden contribuir al bienestar; ninguna técnica garantiza por sí sola un resultado del desarrollo.

Fuentes: [R011] MINSA. Modelo de Cuidado Integral de Salud por Curso de Vida. RM 030-2020/MINSA, 27-01-2020

Salud mental perina d

Las intervenciones psicosocial nes del entorno; la psicoterapia aborda objetivos clínicos medi ita domiciliaria permite valorar necesidades, cuidado y dalidad, no demuestra por sí sola que se haya realizado p

Fuentes: [R013] MINSA. DS 155-MINSA/D por RM 431-2024/MINSA

Lactarios y entornos

Promover lactarios institucional comunitario: modifica el entorno que facilita la lactanci ividual por beneficiar a una madre ni se limita al periodo pre

Fuentes: [R011] MINSA. Modelo de Cuidado Integral de Salud por Curso de Vida. RM 030-2020/MINSA, 27-01-2020

conservan sus licencias

ANCLAS PARA RECORDAR

01	Periodo: desde el cuidado preconcepcional y la gestación hasta el nacimiento.
02	Detectar depresión, ansiedad, riesgo suicida y violencia con respuesta segura.
03	Fortalecer red de apoyo, autocuidado y adherencia a controles.
04	Guía: gestantes de 32 semanas o más conocen la importancia y manejo de la lactancia. HIS: primera consejería entre 25 y 32 semanas. No son el mismo criterio.
05	Secuencia de la leche humana: calostro en los primeros días; leche de transición durante el cambio inicial; y leche madura cuando la producción se estabiliza.
06	Vacunación vigente: influenza en cualquier edad gestacional; Tdap entre 20-36 semanas; vacuna VRS entre 32-36 semanas según NTS vigente.

CLAVE DE EXAMEN **Cad igente, antecedentes y cont**

Fuente: Guía Técnica para la Consejería en GIESP-2026, RM N.° 561-2026-MINSA.

conservan sus licencias

Niña y niño

Comprende desde el nacimiento hasta los 11 años, 11 meses y 29 días. El cuidado vigila crecimiento, desarrollo, apego, crianza, nutrición, inmunizaciones, violencia y señales del neurodesarrollo.

M-CHAT-R/F: interpretar y actuar

Tamizaje de probabilidad de autismo, no diagnóstico ni prueba de TDAH. Validado inicialmente entre 16 y 30 meses; el manual de los autores de marzo de 2025 admite uso hasta 48 meses según estudios posteriores.

- 0-2: probabilidad baja; continuar vigilancia y repetir a los 24 meses si aún no los cumple.
- 3-7: realizar la entrevista de seguimiento de las respuestas de probabilidad elevada. Resultado final ≥2: tamizaje positivo, derivar a eva ención temprana; 0-1: continuar vigilancia.
- 8-20: probabilidad alta; pue tamente a evaluación diagnóstica y valoración para intervención po.

La preocupación clínica o fami je bajo. El rango del manual no modifica por sí mismo las e acional.

Fuentes: [R001] Robins, Fein y Barton. M-C ores M-CHAT. Algoritmo oficial de puntuación

Tamizaje del desarr

Concepto	Cómo	
Preocupación clínica	Recoger hitos, comunicación, juego, audición, contexto familiar y observaciones de cuidadores.	Un tamizaje negativo no cancela una preocupación clínica fundada.
Derivación	Explicar hallazgos y coordinar evaluación e intervenciones según necesidades, sin esperar una etiqueta para apoyar a la familia.	Evitar atribuir diferencias del desarrollo a una mala crianza.

Fuentes de esta ampliación: [A] M-CHAT · Sitio oficial de los autores · [M] OMS · Guía mhGAP, tercera edición, 2023

conservan sus licencias

ANCLAS PARA RECORDAR

01	Edad: 0 a 11 años, 11 meses y 29 días.
02	Promover interacción sensible, juego, lenguaje y entornos protectores.
03	Identificar retrasos o señales de alarma y activar evaluación oportuna.
04	Esquema infantil vigente: vacunas al nacer y series/boosters por edad; verificar siempre la NTS actual.

CLAVE DE EXAMEN **El tamizaje del desarrollo orienta; no reemplaza una evaluación diagnóstica.**

Fuente: Temario oficial MINSA para Psicología y bibliografía institucional vinculada.

conservan sus licencias

TEMA 12 · EJE 02

Adolescente

Comprende de 12 a 17 años, 11 meses y 29 días. La atención debe ser confidencial, amigable, no estigmatizante y sensible a la autonomía progresiva.

Adolescencia: entrada y continuidad del cuidado

1. Atender primero el motivo de consulta y detectar urgencias.

2. Ofrecer luego el paquete integral con el equipo de salud, incluidas salud mental, nutrición, salud bucal y salud sexual y reproductiva, según necesidades, riesgos y prestaciones pendientes; no imponer todas las atenciones en una sola visita.

3. Incluir consejería sobre sexualidad, prevención del embarazo e ITS, vínculos y proyecto de vida. Ofrecer consejería también a padres o cuidadores, preservando la confidencialidad y explicando sus límites legales.

4. La atención puede iniciarse cidad y recursos; debe continuar en el establecimiento de salud

Fuentes: [R014] MINSA. NTS 157-MINSA/2

ANCLAS PARA REC

01	Edad: 12 a 17 año
02	Explorar salud me ilia y proyecto de vida.
03	Explicar límites de c a.
04	VPH se administra según edad y esquema vigente; completar otras vacunas pendientes.

CLAVE DE EXAMEN **La entrevista puede incluir un espacio a solas, respetando marco legal y seguridad.**

Fuente: Temario oficial MINSA para Psicología y bibliografía institucional vinculada.

Convivencia escolar y psicología

La Ley 29719 establece mecanismos para diagnosticar, prevenir, evitar, sancionar y erradicar el acoso y la violencia entre estudiantes. En el SERUMS escolar, la DA 377 de 2025 dispone que el psicólogo integre el Comité de Gestión del Bienestar y el Servicio de Apoyo Educativo Interno; participe en el plan de tutoría, orientación educativa y convivencia escolar (TOECE); trabaje con docentes y familias; y apoye derivación y seguimiento. Su función no se limita a atender casos individuales.

Fuentes: [R015] Ley 29719, publicada 25-06-2011 · [R016] MINSA. DA 377-MINSA/DIGEP-2025. RM 378-2025/MINSA, 04-06-2025

conservan sus licencias

TEMA 13 · EJE 02

Joven

Comprende de 18 a 29 años, 11 meses y 29 días. Se abordan autonomía, relaciones, estudios o trabajo, salud sexual, consumo, violencia y transición a servicios de adultos.

ANCLAS PARA RECORDAR

01	Edad: 18 a 29 años, 11 meses y 29 días.
02	Promover habilidades para decisiones y búsqueda temprana de ayuda.
03	Detectar trastornos frecuentes y riesgo suicida.
04	Revisar esquema iometabólicos.

CLAVE DE EXAMEN **La a e necesidades prev**

Fuente: Temario oficial MINSA para Psicol

conservan sus licencias

TEMA 14 · EJE 02

Persona adulta

Comprende de 30 a 59 años, 11 meses y 29 días. El cuidado considera salud mental, riesgo cardiovascular, cáncer, salud sexual, trabajo, violencias y enfermedades crónicas.

Cuidado integral: de la evaluación al seguimiento

Concepto	Cómo reconocerlo	No confundir
Evaluación general	Integrar dimensiones física, mental y social; comprobar si se completó la evaluación del último año.	No reducir el cuidado integral a atender el motivo de consulta del día.
Plan acordado	Completar evaluaciones pendientes en fe	El plan organiza cuidados; no es una lista de s sin responsables ni o.
Prevención	Re pr cu	áticamente el mismo s edades y condiciones.

Fuentes de esta ampliación: [AD] MINSA ·

ANCLAS PARA REC

01	Edad: 30 a 59 año
02	La NTS 229 actualiza
03	Evaluar hábitos, soporte, estrés, adherencia y funcionamiento.
04	Coordinar seguimiento de comorbilidades y uso seguro de medicamentos.

CLAVE DE EXAMEN **La NTS 229 vigente sustituyó la norma de 2006 y organiza un paquete según necesidades y riesgos.**

Fuente: NTS N.° 229-MINSA/DGIESP-2025, aprobada por RM N.° 310-2025-MINSA.

conservan sus licencias

TEMA 15 · EJE 02

Persona adulta mayor

Comprende desde los 60 años. La atención evalúa funcionalidad, cognición, ánimo, fragilidad, caídas, maltrato, soporte y polifarmacia.

ANCLAS PARA RECORDAR

01	Edad: 60 años a más.
02	Diferenciar delirium, deterioro cognitivo y depresión.
03	Promover autonomía y decisiones con apoyos, evitando infantilización.
04	Vacunación vigen ún esquema.

CLAVE DE EXAMEN **La e alúa para la decisión con**

Fuente: Temario oficial MINSA para Psicol

conservan sus licencias

TEMA 16 · EJE 02

VACAM: breve, corta y completa

La Valoración Clínica del Adulto Mayor (VACAM) avanza por etapas según la capacidad resolutiva del establecimiento. Sus modalidades no deben confundirse con la Valoración Geriátrica Integral (VGI).

ANCLAS PARA RECORDAR

01	VACAM breve: valora las dimensiones funcional, mental, nutricional y social; se aplica principalmente en I-1.
02	VACAM corta: añade fragilidad, valoración sociofamiliar, salud bucal, comorbilidades y síndromes geriátricos; corresponde a I-2, I-3 e I-4.
03	VACAM completa iva de vida o terminalidad y síndromes geriátr
04	VGI: proceso mult lemas médicos, funcionales, ment no es un simple sinónimo de VAC

CLAVE DE EXAMEN **Reg ndo nivel = completa.**

Fuente: NTS N.° 207-MINSA/DGIESP-2023, R

conservan sus licencias

Delirium, deterioro cognitivo y depresión en la persona mayor

Pueden coexistir. El patrón temporal y la atención orientan la primera decisión; una tabla no sustituye evaluación.

Pista	Delirium	Deterioro cognitivo crónico	Depresión
Inicio habitual	Horas o días; cambio respecto al estado previo.	Evolución habitualmente gradual.	Síntomas afectivos persistentes; curso variable.
Atención y curso	Atención alterada y fluctuación; puede ser hipoactivo.	Revisar perfil y evolución; no todo olvido implica demencia.	Puede haber problemas de concentración y quejas cognitivas.
Primera acción	Buscar y atender causas médicas	Evaluación clínica, funcional,	de Evaluar ánimo, funcionamiento, riesgo y causas asociadas.

CASO APLICADO

Una persona de 78 años conve da y somnolienta. La novedad brusca obliga a valor dad» ni se asume demencia.

Solicitar información del funcion mo, sueño, dolor y enfermedades. Una condición co lica automáticamente una descompensación aguda.

En VACAM y en el plan de cuidado, orte y preferencias. La edad, un tamizaje positivo o un diagnóstico no determinan por sí solos incapacidad para todas las decisiones.

Fuentes: [N11].

conservan sus licencias

03

Prioridades sanitarias transversales

La Psicología contribuye a prevención, adherencia, afrontamiento, detección de riesgo y continuidad en múltiples estrategias sanitarias.

EN ESTE RECORRIDO

17 **Prevención y control del d mental**

19 **Esquema Nacional de Vac**

21 **ITS, VIH y hepatitis ada del VIH**

23 **Prevención de transmisión maternoinfantil**

24 **Enfermedades no transmisibles**

25 **Trauma, enfermedades crónicas y raras**

26 **Exposición a metales pesados**

27 **Infecciones asociadas a la atención**

28 **Climaterio, menopausia y salud mental**

29 **Salud bucal preventiva**

OBJETIVO DEL CAPÍTULO

Revisa la ruta, explica cada tema con tus palabras y después practica con casos.

conservan sus licencias

Prevención y control del cáncer

La prevención combina reducción de riesgos, vacunación, tamizaje, diagnóstico oportuno y continuidad del cuidado.

Cáncer	Clave del cuidado
Cuello uterino	La vacunación contra VPH es prevención primaria; el tamizaje y la detección de lesiones precursoras son prevención secundaria.
Mama	Reconocer cambios y facilitar evaluación. La mamografía depende del programa y del riesgo; la ausencia de dolor no descarta patología.
Próstata	Evaluar riesgo y decisiones informadas. El PSA no establece por sí solo un diagnóstico ni una pauta universal de tamizaje.
Colorrectal	Distinguir las pruebas en personas asintomáticas del estudio de síntomas, como sangrado o cambios persistentes.
Piel	Fot ambiantes. Los consejos generales no ree

CUIDADOS PALIATIVOS

Pueden incorporarse tempran edad y según necesidades. Buscan aliviar el sufrimiento y

El aporte psicológico incluye exp , favorecer la participación informada y coordinar la adhere

El tamizaje se dirige a población asi de una persona con síntomas responde a otra finalidad clínica.

Fuente: [N12].

conservan sus licencias

TEMA 18 · EJE 02

Tuberculosis y salud mental

La TB requiere adherencia prolongada, manejo de estigma, apoyo social, evaluación de consumo y síntomas emocionales.

Búsqueda de casos y control de infecciones

Concepto	Cómo reconocerlo	No confundir
Sintomático respiratorio	Persona con tos y flema durante 15 días o más, según la NTS 221. Este criterio operativo orienta la búsqueda de tuberculosis, pero no confirma el diagnóstico.	Contactos, personas vulnerables o con otros hallazgos compatibles pueden requerir evaluación antes de cumplir ese tiempo.
Detección	Re ge co vu de	mecánicamente dos semanas de aluación clínica o el grupo de ar antes.
Búsqueda activa	Id rie pri	n esperar que la persona
Control de infecciones	Co ve confo	ada no reemplaza lujo ni ventilación.
Aporte psicológico	Explorar estigma, barreras de adherencia y apoyo social; acordar soluciones y seguimiento.	Evitar culpabilizar por interrupciones sin investigar barreras de acceso.

Fuentes de esta ampliación: [B] MINSA · NTS 221: prevención y control de tuberculosis · [R089] MINSA. Prevención y control de la tuberculosis

ANCLAS PARA RECORDAR

01	Identificar barreras económicas, familiares y de acceso.
02	Acompañar adherencia sin culpabilizar a la persona.
03	Coordinar ante efectos adversos, abandono o riesgo psicosocial.

CLAVE DE EXAMEN **La adherencia es un fenómeno del sistema y contexto, no solo voluntad individual.**

Fuente: Temario oficial MINSA para Psicología y bibliografía institucional vinculada.

conservan sus licencias

Tuberculosis: infección, enfermedad y cuidado continuo

El resumen ya incluye búsqueda de casos y control de infecciones. Este contraste ayuda a evitar decisiones basadas solo en una etiqueta.

Distingue	Implicación
Infección / enfermedad	Tener infección por el bacilo no equivale a enfermedad activa. La enfermedad exige evaluación diagnóstica; el riesgo de transmisión depende del cuadro y la localización.
Tamizaje / diagnóstico	Síntomas o una prueba de detección orientan la ruta; no reemplazan el algoritmo diagnóstico vigente.
Adherencia / obediencia	Comprender y sostener el tratamiento requiere acceso, manejo de efectos adversos y acuerdos; culpabilizar puede ocultar las barreras.
Apoyo / exposición de identida	fidencialidad. Un diagnóstico no dad.

CONSEJERÍA QUE PRODUCE UN PL

«¿Qué parte del tratamiento le horario, temor o efectos adversos. Acordar una soluci si fue posible cumplirla.

La atención psicológica explora to. No indica por sí sola el esquema farmacológico ni sustit rotección respiratoria. Las duraciones, pruebas y pautas se co

Fuentes: [N23].

conservan sus licencias

TEMA 19 · EJE 02

Esquema Nacional de Vacunación

El esquema vigente ordena 23 vacunas y un anticuerpo monoclonal según edad, condición y pertenencia a grupos especiales. Para estudiarlo, sigue la secuencia desde el nacimiento hasta la persona mayor. Distingue el nirsevimab: brinda inmunización pasiva contra el VRS, mientras las vacunas inducen una respuesta activa. Después de la aplicación también se vigila la seguridad. Un ESAVI indica que el evento ocurrió después de la vacunación y debe atenderse, notificarse e investigarse; no demuestra por sí solo que la vacuna lo causó. Esta edición utiliza la NTS N.° 246 y la Directiva Sanitaria N.° 054-MINSA/DGE-V.01.

CONCEPTOS QUE SOSTIENEN EL TEMA

Vacuna
Producto biológico que estimu nal que ofrece inmunización inmunitaria activa y memoria f s respiratorio sincitial; no genera la enfermedad. una.

Serie primaria
Conjunto inicial de dosis neces mantener o recuperar la protección adecuada según ed

ESAVI
Cuadro clínico ocurrido despu vigilancia prioritaria por su inmunización y asociado temp e inmediatamente a esa proximidad confirme necesari ión e investigación. causal.

conservan sus licencias

TABLA 1 · NACIMIENTO, PRIMER AÑO Y ESQUEMA VIH

Edad	Vacunas o protección	Regla para memorizar
Nacimiento	BCG + hepatitis B + nirsevimab	Tres protecciones al nacer; nirsevimab no es vacuna
2 meses	Hexavalente 1 + rotavirus 1 + neumococo 1	Comienza las tres series
4 meses	Hexavalente 2 + rotavirus 2 + neumococo 2	Repite el bloque de los 2 meses
6 meses	Hexavalente 3 + influenza 1	Cierra hexavalente; inicia influenza
7 meses	Influenza 2	Segunda dosis un mes después
12 meses	SPR 1 + neumococo 3 + varicela + influenza anual	Cuatro hitos al cumplir un año
13 y 15 meses	Meningococo: dosis 1 y 2 en m	Esquema especial para VIH

Transición del esqu

Pentavalente + IPV o hexavale existencias.

No añadir IPV cuando se admi vigente.

Meningococo a los 13 y 15 me turidad.

Fuente: NTS N.° 246-MINSA/D

TABLA 2 · SEGUNDO PECIALES

Edad o grupo	Vacunas	Regla para memorizar
15 meses	Fiebre amarilla + hepatitis A	Dos vacunas en el mes 15
18 meses	DPT + IPV o hexavalente: 1.er refuerzo; SPR: segunda dosis	Refuerzo DPT/polio + segunda SPR
4 años	DPT 2.º refuerzo + polio oral 2.º refuerzo	Segundo refuerzo doble
9 a 18 años	VPH en dosis única	Casos especiales: revisar pauta propia
Gestante	Influenza en cualquier trimestre + Tdap 20-36 sem. + VRS 32-36 sem.	Revisar en cada embarazo
Adulto con esquema incompleto	Hepatitis B, SR y fiebre amarilla según antecedente, riesgo o zona	No reiniciar series: completar
60 años a más	Influenza anual + una dosis de neumococo	Influenza cada año; neumococo una vez

conservan sus licencias

Observación tras vacunación contra dengue

Tras la vacuna contra el dengue, mantener a la persona sentada en observación por lo menos 30 minutos, conforme a la NTS 243 (2026). Si aparece una reacción, prolongar la vigilancia y activar atención inmediata según gravedad. Explicar signos de alarma y cómo consultar. Este tiempo no debe extrapolarse sin revisión a todas las vacunas.

Fuentes: [R094] MINSA. Vacunación contra el dengue · [R095] MINSA. Modificación de NTS 243 de vacunación contra el dengue

ESAVI · DE LA DETECCIÓN A LA INVESTIGACIÓN

01	Detectar Reconocer el cuadro ocurrido después de la vacunación y valorar su gravedad. · ESAVI es una definición operativa basada inicialmente en temporalidad.
02	Atender Estabilizar y brindar la atención clínica que corresponda; la vigilancia no retrasa el manejo. · Primero se protege a la persona.
03	Comunicar Si es severo, co el establecimiento. · La comunicación a
04	Notificar Registrar con inf ntes relevantes. · Un reporte complet
05	Investigar Evaluar causas c ncia disponible. · La causalidad se dete poral.

conservan sus licencias

ANCLAS PARA RECORDAR

01	Primer año: ordena la secuencia por nacimiento, 2, 4, 6, 7 y 12 meses; luego ubica los hitos de 15 y 18 meses.
02	Recién nacido: BCG, hepatitis B y nirsevimab; este último brinda protección pasiva frente al virus respiratorio sincitial.
03	Infancia: series de hexavalente, rotavirus, neumococo, influenza, meningococo y luego SPR, varicela, fiebre amarilla, hepatitis A y refuerzos.
04	Gestante: influenza en cualquier trimestre; Tdap entre 20 y 36 semanas y vacuna contra VRS entre 32 y 36 semanas en cada embarazo.
05	VPH: esquema primario, dosis única de 9 a 18 años; revisar casos especiales.
06	Personas de 60 años a más: influenza anual y una dosis de neumococo, verificando antecedentes.
07	ESAVI significa ev ión o inmunización: la asociación es tem r sí sola causalidad.
08	Ante un ESAVI se amente a Epidemiología y se inicia la notifi

CLAVE DE EXAMEN	**Nirs ción causada por la vac ntas diferentes.**

Fuente: NTS N.° 246-MINSA/DGIESP-2026, R .01, RM N.° 063-2014-MINSA.

conservan sus licencias

Inmunizaciones en la infancia

Línea de tiempo de repaso · Esquema general de 0 a 4 años · NTS 246-2026

Una edad por fila; dosis y refuerzos a la vista.
El esquema incompleto y los grupos especiales se revisan aparte. Nirsevimab es un anticuerpo monoclonal, no una vacuna.

Recién nacido	BCG + hepatitis B: dosis únicas. **Nirsevimab:** inmunización pasiva frente al VRS.
2 meses	Pentavalente + IPV **o** hexavalente [1]: primeras dosis. Rotavirus + neumococo: primeras dosis.
4 meses	Pentavalente + IPV **o** hexavalente [1]: segundas dosis. Rotavirus + neumococo: segundas dosis.
6 y 7 meses	**6 meses:** te [1]; primera influenza pediátrica. **7 meses:**
12 meses	SPR: pri Varicela:
15 meses	Antiamar dosis úni
18 meses	Primer refu SPR: segunda dosis.
2, 3 y 4 años	**2 años:** influenza pediátrica + segunda varicela [2]. **3 años:** influenza adulto. **4 años:** influenza adulto + segundo refuerzo DPT + segundo refuerzo APO.

Las notas forman parte del esquema
[1] La hexavalente se aplica tras agotar existencias de pentavalente e IPV. Si se aplica hexavalente, no se añade IPV como dosis separada.
[2] La segunda dosis de varicela se incorpora progresivamente.
Nirsevimab entre 1 y 6 meses: si no se recibió en el período neonatal o se considera de alto riesgo, según los criterios de la norma.

Abreviaturas: IPV = polio inactivada; APO = polio oral; SPR = sarampión, paperas y rubéola; DPT = difteria, pertussis y tétanos; VRS = virus respiratorio sincitial.

Fuente: NTS 246-MINSA/DGIESP-2026, parte 1, pp. 45-47, apartados 6.2.2 y notas. RM 561-2026-MINSA.

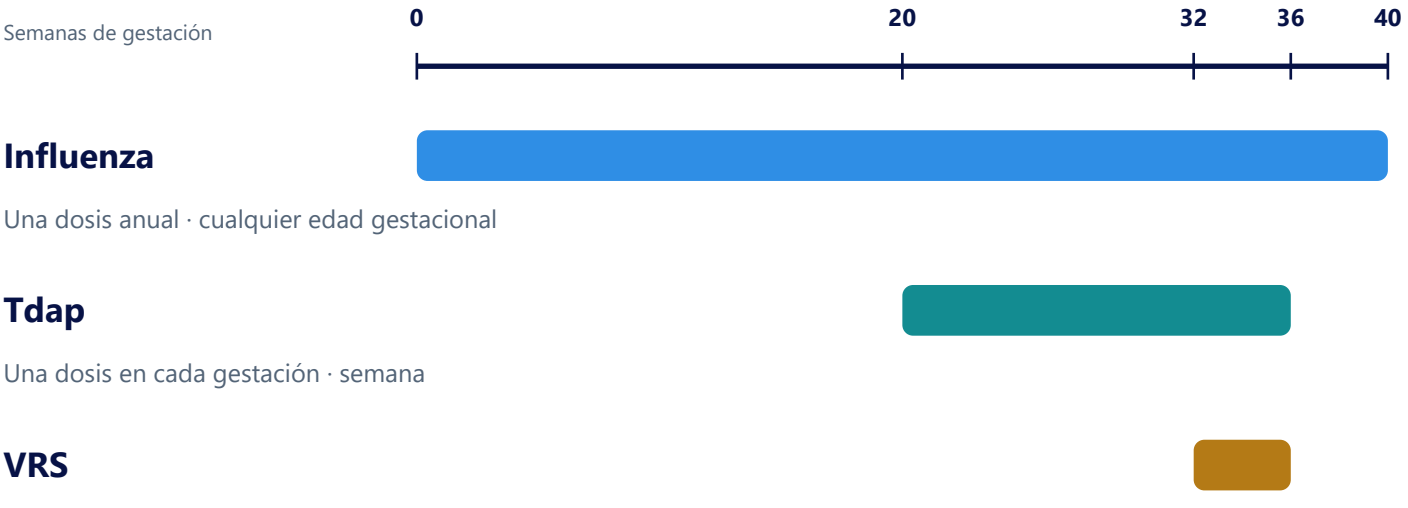
conservan sus licencias

Protección por curso de vida

Tres momentos para recordar · Complemento de la lámina infantil

GESTACIÓN

Ventanas que conviene visualizar



Si faltan dosis previas: hepatitis B ema indicado. La línea superior muestra las ventanas de rutina; no s

9 a 18 años

VPH: una dosis, según esquema primario.

La norma distribuye este grupo entre niñez, adolescencia y los 18 años. Los grupos especiales tienen indicaciones diferentes.

s

Influenza: anual.
Neumococo: dosis única en el esquema del adulto mayor, revisando antecedentes.

No repetir automáticamente una dosis ya recibida.

Alcance de estas dos láminas
La recuperación de esquemas, el VIH, otras condiciones clínicas y las situaciones de brote requieren consultar sus indicaciones específicas en la norma. No deben confundirse con la pauta general aquí resumida.

Fuente: NTS 246-MINSA/DGIESP-2026, parte 1, pp. 45 y 47-49, apartados 6.2.1 y 6.2.3-6.3. RM 561-2026-MINSA.

conservan sus licencias

TEMA 20 · EJE 02

Anemia

La prevención combina alimentación, suplementación, tamizaje y tratamiento según edad y condición, con acompañamiento para adherencia.

Reconocimiento y confirmación

Concepto	Cómo reconocerlo	No confundir
Sospecha	Fatiga, palidez, mareo, menor tolerancia al esfuerzo o dificultad de concentración pueden orientar.	Son manifestaciones inespecíficas: no diagnosticar solo por apariencia o cansancio.
Confirmación	Hemoglobina interpretada con cri fis cu	Anemia no equivale siempre a deficiencia de e investigarse su causa.
Continuidad	A de se ad	ultades cognitivas mia sin evaluación integral.

Fuentes de esta ampliación: [N] OMS · Ana

ANCLAS PARA REC

01	Explorar creencias, t
02	Reforzar indicaciones sin reemplazar evaluación clínica y nutricional.
03	Monitorear cumplimiento y retorno al control.

CLAVE DE EXAMEN **La consejería efectiva identifica la barrera concreta antes de repetir instrucciones.**

Fuente: Temario oficial MINSA para Psicología y bibliografía institucional vinculada.

conservan sus licencias

TEMA 21 · EJE 02

ITS, VIH y hepatitis

La atención integra prevención, pruebas con consentimiento, tratamiento, confidencialidad y reducción del estigma.

Consejería y periodo ventana

Antes de la prueba: explorar exposición sin juicios, explicar procedimiento, posibles resultados, confidencialidad, consentimiento y periodo ventana.

Al entregar el resultado: ofrecer consejería tanto si es reactivo como no reactivo. Un resultado reactivo activa el algoritmo diagnóstico y la vinculación; uno no reactivo requiere valorar el tiempo desde la exposición y acordar nuevas pruebas cuando corresponda.

Una prueba negativa una semana después de una exposición no descarta VIH. La ventana depende de la prueba utilizada y puede verse plazo único aplicable a todas las pruebas. Mantener prevención

Fuentes: [R029] MINSA. NTS 204-MINSA/ Testing, actualización 17-08-2026

Adherencia al trata

Ante dificultades para continu barreras concretas: efectos adversos, acceso, horarios, esti ol u otras sustancias. Acordar soluciones con la pers pares cuando lo acepte. La tristeza no demuestra consum herencia.

Fuentes: [R031] MINSA. NTS 169-MINSA/2020 ence to the Continuum of Care, actualización 12-09-2024

ANCLAS PARA RECORDAR

01	Consejería centrada en riesgo real y decisiones informadas.
02	Promover preservativo, vacunación indicada, diagnóstico y vinculación a atención.
03	Evitar lenguaje moralizante y revelar información sin autorización.

CLAVE DE EXAMEN **La prueba requiere información y confidencialidad; un resultado reactivo puede necesitar confirmación.**

Fuente: Temario oficial MINSA para Psicología y bibliografía institucional vinculada.

conservan sus licencias

TEMA 22 · EJE 02

Prevención combinada del VIH

Integra herramientas biomédicas, conductuales y estructurales según necesidades y exposición.

LA COMBINACIÓN RESPONDE AL RIESGO Y A LA PREFERENCIA

Componente	Incluye	Propósito
Biomédico	PrEP, PEP, TAR, pruebas y preservativos	Reducir adquisición y transmisión
Conductual	Información, habilidades y reducción de daño	Favorecer decisiones posibles
Estructural	D es	arreras del entorno

Educador de pares

Es una persona de la població para ofrecer educación en salud, apoyo emocional y aco ida facilita confianza y vinculación con los servicios. E la adherencia; no sustituye la evaluación profesional ni au

Fuentes: [R031] MINSA. NTS 169-MINSA/2

ANCLAS PARA RECORDAR

01
Preservativos, pruebas, tratamiento como prevención, PrEP y PEP según indicación.

02
Educación sexual, reducción de daño y habilidades de negociación.

03
Acceso sin estigma, derechos y reducción de barreras estructurales.

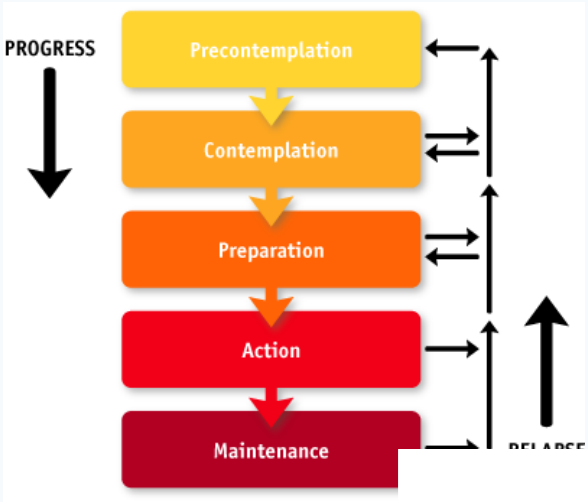
CLAVE DE EXAMEN **Combinada significa elegir y articular varias estrategias, no una intervención única.**

Fuente: Temario oficial MINSA para Psicología y bibliografía institucional vinculada.

conservan sus licencias

Motivación y cambio: ajustar la conversación

El modelo de etapas sirve como orientación; las personas no avanzan siempre en orden ni permanecen en una sola etapa para todas las conductas.



Toddatkins · CC0. Sin recorte; escala proporcion

Fuente

Situación	Respuesta útil
No identifica una necesidad de cambio	Explorar su perspectiva y ofrecer información con permiso.
Ve ventajas y costos de cambiar	Escuchar ambivalencia y evocar razones propias.
Desea actuar	Acordar una meta concreta y recursos para empezar.
Ya está cambiando	Revisar dificultades, apoyos y ajustes sostenibles.
	Analizar qué ocurrió y retomar; evitar tratarlo como fracaso moral.

CASO APLICADO

«Sé que tomar me trae proble
ayuda a desconectarme». La pi
ambivalencia: explorar ambas
razones de cambio. Confronta
riesgos no garantiza una decis

Fuentes: [N14].

conservan sus licencias

TEMA 23 · EJE 02

Prevención de transmisión maternoinfantil

La detección oportuna y el tratamiento durante embarazo, parto y puerperio reducen transmisión de VIH, sífilis y hepatitis B.

Prueba rápida dual en la atención materna

La prueba rápida dual VIH/sífilis detecta anticuerpos frente a ambas infecciones en un mismo procedimiento. La NTS 159 la establece como prueba de elección para el tamizaje durante atención prenatal, parto, emergencia obstétrica y puerperio. No incluye hepatitis B: su tamizaje requiere la prueba correspondiente. Interpretar cada resultado y continuar el algoritmo específico, sin confundir tamizaje reactivo con diagnóstico completo.

Fuentes: [R033] MINSA. NTS 159-MINSA/2

ANCLAS PARA REC

01	Tamizaje y vincul
02	Adherencia, sopo
03	Coordinación del

CLAVE DE EXAMEN **La con rtante como el tamizaje.**

Fuente: Temario oficial MINSA para Psicología y bibliografía institucional vinculada.

conservan sus licencias

TEMA 24 · EJE 02

Enfermedades no transmisibles

Diabetes, hipertensión, obesidad y otras ENT comparten riesgos y requieren autocuidado sostenido.

Estilo de vida y autocuidado

Estilo de vida es un patrón habitual de comportamientos moldeado por características personales y condiciones sociales y ambientales. Una práctica aislada no basta para describirlo. El autocuidado reúne acciones para conservar la salud y afrontar enfermedad; puede incluir actividad física, alimentación, tratamiento y búsqueda de ayuda. Las oportunidades reales para sostener estas prácticas también importan.

Fuentes: [R079] OMS. Health Promotion Glossary · [R078] OMS. Primary health care

conservan sus licencias

ANCLAS PARA RECORDAR

01	Entrevista motivacional y metas graduales favorecen cambio.
02	Evaluar depresión, estrés, consumo, sueño y soporte.
03	Evitar atribuir descontrol únicamente a falta de voluntad.

Riesgo y protección en ENT

Riesgos compartidos de ENT: tabaco, alimentación no saludable, inactividad física y consumo nocivo de alcohol; también influyen contaminación y condiciones sociales. Obesidad, presión arterial elevada y alteraciones de glucosa o lípidos incrementan riesgo cardiometabólico. La actividad física ayuda a prevenir obesidad, diabetes tipo 2 y enfermedad cardiovascular, no una sola enfermedad. Precisar el patrón de alcohol: «consumo» sin dosis ni contexto no demuestra que sea el principal riesgo de diabetes. Dolor torácico con disnea exige evaluación urgente; no atribuirlo de entrada a ansiedad.

Fuentes: [R080] OMS. Enfermedades no transmisibles · [R081] OMS. Actividad física · [R082] CDC. About Heart Attack Symptoms, Risk, and Recovery

CLAVE DE EXAMEN **Una** **comendación general.**

Fuente: Temario oficial MINSA para Psicol

conservan sus licencias

TEMA 25 · EJE 02

Trauma, enfermedades crónicas y raras

El impacto incluye incertidumbre, dolor, discapacidad, cambios de rol, duelo y carga familiar.

ANCLAS PARA RECORDAR

01	Contención inicial, información dosificada y apoyo práctico.
02	Evaluar riesgo, funcionamiento, soporte y necesidades del cuidador.
03	Coordinar rehabilitación, paliativos, protección social y grupos de apoyo.

CLAVE DE EXAMEN **Con seg** **; es acompañar con**

Fuente: Temario oficial MINSA para Psicol

conservan sus licencias

Contención, duelo y cuidados paliativos

Los cuidados paliativos pueden incorporarse tempranamente según necesidades, junto con tratamientos dirigidos a la enfermedad. No se reservan al final de la vida.

Necesidad	Respuesta psicológica y coordinación
Malestar inmediato	Escuchar, validar y aclarar qué necesita ahora; información comprensible y dosificada.
Dolor o síntomas físicos	Coordinar evaluación y manejo con el equipo; no atribuirlos automáticamente a ansiedad.
Incertidumbre y pérdidas	Explorar significados, objetivos posibles, valores y apoyos. El duelo no sigue etapas obligatorias.
Familia y cuidador	Valorar sobrecarga, descanso, comunicación y acceso a ayuda, respetando la decisión de la persona.
Seguridad y seguimiento	ponsables, continuidad y acceso a

NO EQUIVALE A ABANDONAR EL T

Paliar busca aliviar sufrimiento ir con tratamiento oncológico u otros tratamient

Evitar prometer curación, exigir de psicoterapia u otra atención se determina por evalu encias; no solo por el diagnóstico médico.

Fuentes: [N12].

conservan sus licencias

TEMA 26 · EJE 02

Exposición a metales pesados

Requiere identificar fuente, tiempo, población expuesta, manifestaciones y ruta sanitaria/ambiental.

Mercurio y plomo: pistas de exposición

Mercurio: según su forma química y vía de exposición, puede producir temblor, alteraciones del ánimo, sueño o memoria, y lesiones orales como gingivitis o hipersalivación. La combinación con un antecedente compatible orienta la evaluación; los síntomas aislados no confirman intoxicación. Plomo: investigar pinturas y polvo contaminados, cerámica vidriada y productos o juguetes con pigmentos no seguros. En la niñez, llevar objetos a la boca facilita la ingestión. No todo lápiz o juguete contiene plomo: verificar composición, procedencia y fuente.

Fuentes: [R090] MINSA. Guía de práctica cl r mercurio · [R091] OMS. Almost 1 million people die every year due to lead poisoni

Clave oficial observ

Concepto	Có	
Examen histórico	Ps cl ep	r sugería una secuencia ir a otra alternativa.
Lectura clínica	La la ev proto mercurio.	ernativa marcada en una retrase proteger a las
Regla para estudiar	Conservar la clave oficial cuando se revisa ese examen; diferenciarla del manejo técnico de una exposición real.	No cambiar silenciosamente una clave histórica para hacerla coincidir con una explicación.

Fuentes de esta ampliación: [E] MINSA · Cuadernillo oficial Psicología 2026-II

conservan sus licencias

ANCLAS PARA RECORDAR

01	Niñez y gestación pueden tener mayor vulnerabilidad.
02	Comunicar riesgo sin alarmismo ni minimización.
03	Coordinar vigilancia sanitaria y epidemiológica, evaluación clínica y control de la fuente.
04	Ante exposición a metales, seguir el protocolo específico del agente y activar evaluación y vigilancia. No extrapolar a todos los metales una secuencia fija de lavado y notificación.

CLAVE DE EXAMEN **Tratar a la persona sin controlar la fuente mantiene la exposición.**

Fuente: Temario oficial MINSA para Psicología y bibliografía institucional vinculada.

conservan sus licencias

TEMA 27 · EJE 02

Infecciones asociadas a la atención

Las IAAS se previenen con vigilancia, higiene, procedimientos seguros, limpieza y uso racional de antimicrobianos.

Definición y vigilancia de IAAS

Una IAAS se relaciona con la atención sanitaria y no estaba presente ni en incubación al ingreso, salvo vínculo con atención previa; también comprende infecciones ocupacionales del personal sanitario. En la NTS 163, la vigilancia es selectiva porque observa pacientes con riesgos extrínsecos priorizados; focalizada porque concentra recursos en servicios, dispositivos y procedimientos seleccionados; activa porque busca casos intencionalmente; y permanente porque mantiene continuidad. Estas características se complementan: seleccionar neonatología no demuestra, por sí solo, cómo se buscaron los casos.

Fuentes: [R065] MINSA. Vigilancia de las in

ANCLAS PARA REC

01	Cumplir precauci
02	La vigilancia perm ncias y detectar un incremento o con
03	Notificar, investig
04	La cultura de seguri

CLAVE DE EXAMEN **La higiene de manos es central, pero forma parte de un sistema de prevención.**

Fuente: Temario oficial MINSA para Psicología y bibliografía institucional vinculada.

conservan sus licencias

TEMA 28 · EJE 02

Climaterio, menopausia y salud mental

Los síntomas se interpretan considerando cambios biológicos, contexto, sueño, relaciones y salud general.

ANCLAS PARA RECORDAR

01	Evitar patologizar automáticamente una transición vital.
02	Detectar depresión, ansiedad, violencia y deterioro funcional.
03	Promover decisiones informadas y coordinación interdisciplinaria.

CLAVE DE EXAMEN **Sínt atri** **evaluación; no deben**

Fuente: Temario oficial MINSA para Psicol

conservan sus licencias

Climaterio y menopausia: comprender la transición

La menopausia natural se reconoce retrospectivamente tras 12 meses consecutivos sin menstruación, sin otra causa evidente ni intervención que lo explique.

Concepto	Qué conviene distinguir
Menopausia	Hito relacionado con el final de la función folicular; no es por sí mismo un trastorno mental.
Transición menopáusica	Cambios del ciclo y síntomas que pueden preceder al último periodo; experiencias variables.
Climaterio	Término más amplio usado para la transición entre etapas reproductiva y no reproductiva. No es idéntico al hito de la última menstruación.
Salud mental	iento, sexualidad, relaciones y nales.

CASO APLICADO

Una mujer refiere insomnio y á contexto relevante, pero no excluye depresión, violenci no una explicación automática.

Ofrecer información clara, decisi ndo corresponda. Las indicaciones de terapia hormona dica individual; el resumen no establece una pauta universal.

Fuentes: [N13].

conservan sus licencias

TEMA 29 · EJE 02

Salud bucal preventiva

La salud bucal se relaciona con alimentación, autoestima, comunicación y enfermedades crónicas.

ANCLAS PARA RECORDAR

01	Cepillarse con pasta dental fluorada como mínimo dos veces al día; el cepillado nocturno es especialmente importante.
02	Usar hilo dental al menos una vez al día, antes del cepillado nocturno; no reemplaza el cepillado.
03	Promover aliment
04	Identificar miedo
05	Derivar ante dolo

CLAVE DE EXAMEN **Me** **cont** **lo dental diario +**

Fuente: Dirección de Salud Bucal del MINS ente.

conservan sus licencias

EJE 02 · CIERRE DE REPASO

Lo que debes poder explicar

Si una idea todavía no sale con tus propias palabras, vuelve al tema antes de practicar.

01 **Curso de vida: prenatal; 0-11; 12-17; 18-29; 30-59; 60 años a más.**

02 **VACAM: I-1 breve; I-2 a I-4 corta; segundo nivel completa; VGI no es sinónimo automático.**

03 **Nirsevimab brinda inmunización pasiva frente al VRS; no es una vacuna.**

04 **ESAVI describe una relación temporal que exige atención y evaluación; no confirma causalidad.**

05 **En salud mental se prioriza ntes de completar el diagnóstico.**

NO LOS CONFUNDAS

VACAM / VGI	disciplinaria
Tamizaje / diagnóstico	
Referencia / abandono	Traslada con continuidad / corta responsabilidad asistencial

RECUERDA SIN MIRAR

1. **¿Qué modalidad VACAM corresponde a una IPRESS I-3?**
2. **¿Qué diferencia un ESAVI de una reacción causalmente atribuida?**
3. **¿Qué dato obliga a priorizar seguridad en una atención psicológica?**

conservan sus licencias

Practica y comprueba

Casos originales . Responde antes de leer la explicación. La mención de una clave histórica se identifica expresamente.

CASO 01 · ORIGINAL

Una persona evita viajar y siente alivio al cancelar. ¿Qué hipótesis funcional explorarías?

Respuesta razonada. El alivio puede reforzar negativamente la evitación. Confirmar antecedentes y consecuencias; no asumir la función solo por la forma de la conducta.

CASO 02 · ORIGINAL

Se programan actividades con sentido y se contrastan pensamientos automáticos. ¿Qué técnicas reconoces?

Respuesta razonada. Activació ompatibles con un abordaje cognitivo conductual.

CASO 03 · ORIGINA

Un tamizaje de autismo resul

Respuesta razonada. Indica ne oritmo; por sí solo no confirma TEA.

conservan sus licencias

Fuentes de referencia

[T] MINSA · Temario de Psicología SERUMS 2026-II

Contenidos temáticos por carrera; publicación del 22/07/2026.

[E] MINSA · Cuadernillo oficial Psicología 2026-II

Preguntas 1, 4, 14, 21, 26, 28, 40, 46, 50, 52, 76 y 87. Claves históricas conservadas.

[ABC] Albert Ellis Institute · Modelo ABC

Acontecimientos, creencias y consecuencias emocionales y conductuales.

[M] OMS · Guía mhGAP, tercera edición, 2023

Intervenciones psicológicas, depresión, ansiedad y trastornos del neurodesarrollo.

[EXP] APA · What is exposure therapy?

Exposición y desensibilización sistemática.

[OC] Investigación histórica · Sobrecorrección

Restitución y práctica positiva, estudio de 1979. Referencia conceptual histórica, no recomendación clínica actual.

[D] OMS · Mental disorders

Secciones sobre depresión, ansiedad, neurodesarrollo.

[VIO] MIMP · Protocolo de actuación conjunta CEM de salud

olencia y principio de no revictimización.

[A] M-CHAT · Sitio oficial de

Finalidad del tamizaje y condiciones d instrumento.

idado integral de la

general y plan de atención

[C] OMS · Cancer

Prevención, diagnóstico temprano y t

ención y control de

e casos y control de infecciones.

[N] OMS · Anaemia

Manifestaciones, causas y confirmación c

Documentos consultados

[R001] Robins, Fein y Barton. M-CHAT-R/F, actualización terminológica de marzo de 2025

PDF pp. 2 y 4: algoritmo, edades y derivación por preocupación clínica.

[R002] Autores M-CHAT. Algoritmo oficial de puntuación

0-2, 3-7, 8-20.

[R003] MINSA. Guía de práctica clínica para tamizaje, diagnóstico y tratamiento de la depresión en mayores de 18 años. RM 136-2023/MINSA, 10-02-2023

Anexo: definiciones, instrumentos y manejo de depresión leve; PDF pp. 4, 12 y 27-28.

[R004] MINSA/OMS. Enfrentando Problemas Plus grupal, edición castellana

Anexos de evaluación: SRQ-20 y PHQ-9; elección contextual de instrumento.

[R005] OMS. Mental disorders

Apartado Neurodevelopmental disorders; consultado 19-10-2026.

[R006] Reglamento de la Ley 29414. DS 027-2015-SA, 13-08-2015

Artículo 19: respeto de la dignidad e intimidad; buen trato y no discriminación.

conservan sus licencias

[R007] MINSA. NTS 201-MINSA/DGIESP-2023, estándares de calidad para establecimientos que brindan cuidado integral de adolescentes. RM 356-2023/MINSA, 03-04-2023

Estándares de privacidad, confidencialidad y atención respetuosa.

[R008] US Department of Veterans Affairs, National Center for PTSD. Alternative Treatments

Relaxation training: respiración y relajación muscular; distinción frente a tratamientos específicos de TEPT.

[R009] US Department of Veterans Affairs. Coping with Traumatic Stress Reactions

Relajación: adaptación si aumenta inicialmente el malestar.

[R010] US Military Health System. Stress Reduction Techniques for High Stress Operations

Skills That Aid Job Performance Under High Stress: respiración diafragmática y relajación muscular progresiva; consultado 19-10-2026.

[R011] MINSA. Modelo de Cuidado Integral de Salud por Curso de Vida. RM 030-2020/MINSA, 27-01-2020

Anexo: principios, §6.3 y cuidados prenatales; PDF pp. 41, 46-47 y 52.

[R012] MINSA. Manual de implementación del MCI. RM 220-2021/MINSA, 12-02-2021, publicada 15-02-2021

Anexo PDF pp. 10 y 28: PAIFAM e intervención participativa en la unidad familiar.

[R013] MINSA. DS 155-MINS blicada 21-02-2024; modificada por RM 431-2024/MINSA

Anexo §6.5.3.c, PDF pp. 20-21: intervencio ón de 2024 no altera este apartado.

[R014] MINSA. NTS 157-MIN 2019

PDF pp. 20-22, 27 y 33; anexos de atenció

[R015] Ley 29719, publicada

Arts. 1-3; leer con modificaciones de la Le

[R016] MINSA. DA 377-MINS 5

Anexo §6.6.2, PDF p. 11: funciones de psicólo

[R021] MINSA. Guía técnica de A, publicada 14-07-2023; edición 2024

p. 15, definición de continuidad y componentes clínico, psicosocial y de gestión.

[R022] MINSA. Plan nacional de fortalecimiento de servicios de salud mental comunitaria 2018-2021. RM 356-2018/MINSA

p. 40: principios conceptuales de cuidado integral, continuidad y recuperación.

[R023] MINSA. Guía técnica de salud mental de mujeres en situación de violencia por pareja o expareja. RM 670-2021/MINSA, 26-05-2021

Anexo PDF pp. 9-10, 22 y 25-26: riesgo, complejidad, primer nivel y referencia.

[R024] MINSA. NTS 164-MINSA/2020/DGIESP, RM 649-2020/MINSA, 20-08-2020

Edición explicativa oficial, p. 33: seis componentes AVISAS; atención centrada en la víctima.

[R025] MINSA. NTS 164, texto aprobado por RM 649-2020/MINSA

PDF pp. 19-20 y 24: consentimiento para cada intervención y examen; apartados de atención clínica y kit según evaluación.

[R026] OMS. Guidelines for HIV post-exposure prophylaxis, 22-07-2024

Inicio lo antes posible, idealmente en 24 horas y no después de 72; duración de 28 días.

[R027] Reglamento de la Ley 30364, art. 15.1, modificado por DS 004-2019-MIMP, 07-03-2019

conservan sus licencias

Denuncia de profesionales de salud y educación, directamente ante PNP, Ministerio Público o Poder Judicial.

[R028] Código Penal, art. 173, redacción de la Ley 30838, publicada 04-08-2018; texto citado por el Tribunal Constitucional en 2026

Fundamento 11, delito de violación sexual de menor de catorce años.

[R018] MIMP. Lineamientos de coordinación CEM-UPE-DEMUNA. RM 237-2024-MIMP, 13-07-2024

Anexo §§7.1.3-7.2.4, PDF pp. 14-16: competencias y coordinación.

[R029] MINSA. NTS 204-MINSA/DGIESP-2023. RM 576-2023/MINSA (2023)

§6.2.1, p. 20: consejería pretest, postest y reducción de riesgos.

[R030] CDC. HIV Testing, actualización 17-08-2026

Apartados Types of HIV tests y Confirming test results: ventana según prueba y efecto de antirretrovirales; consultado 19-10-2026.

[R031] MINSA. NTS 169-MINSA/2020/DGIESP. RM 1024-2020/MINSA, 11-12-2020

Definiciones operativas: educador de pares, PDF p. 9; responsabilidades de psicología, §6.1.4, PDF pp. 16-17.

[R032] NIH. Adherence to the Continuum of Care, actualización 12-09-2024

Evaluación individual de barreras, salud mental, consumo, acceso y apoyo colaborativo.

[R033] MINSA. NTS 159-MIN 13-12-2019

Definiciones de PRD y §6.1.1, tamizaje mat .

[R065] MINSA. Vigilancia de l a salud

4.1 a y c; páginas impresas 2-3 (PDF 4-5)

[R079] OMS. Health Promoti

Entrada Lifestyle (lifestyles conducive to h

[R078] OMS. Primary health c

Servicios integrados, acción multisectorial

[R080] OMS. Enfermedades n

Factores conductuales, ambientales y metaból

[R081] OMS. Actividad física

Beneficios en obesidad, diabetes tipo 2 y enfermedades cardiovasculares

[R082] CDC. About Heart Attack Symptoms, Risk, and Recovery

Dolor torácico y disnea: atención inmediata

[R089] MINSA. Prevención y control de la tuberculosis

5.2.37, página impresa 19: sintomático respiratorio; búsqueda activa

[R090] MINSA. Guía de práctica clínica para el diagnóstico y tratamiento de la intoxicación por mercurio

Anexo 4, página impresa 23: manifestaciones según forma química

[R091] OMS. Almost 1 million people die every year due to lead poisoning

Fuentes de exposición infantil: pinturas, juguetes, polvo, cerámica, productos contaminados

[R094] MINSA. Vacunación contra el dengue

6.8.4, página impresa 9 (PDF 11): observación por lo menos 30 minutos

[R095] MINSA. Modificación de NTS 243 de vacunación contra el dengue

Modifica Anexo 1 (presentación de vacuna); no modifica 6.8.4

conservan sus licencias

Índice de temas

Tema	Página
01 Evaluación psicológica	4
02 Entrevista, observación y examen mental	6
03 Atención y continuidad en salud mental	8
04 Psicoterapias basadas en evidencia	9
05 Problemas prioritarios de salud mental	13
06 Rapport y comunicación clínica	18
07 Aspectos legales de la atención psicológica	19
08 Atención Primaria de Salud	23
09 Modelo de cuidado integral por curso de vida	24
10 Gestante y periodo prenatal	27
11 Niña y niño	29
12 Adolescente	31
13 Joven	32
14 Persona adulta	33
15 Persona adulta mayor	34
16 VACAM: breve, corta y complet	35
17 Prevención y control del cáncer	38
18 Tuberculosis y salud mental	39
19 Esquema Nacional de Vacunaci	41
20 Anemia	47
21 ITS, VIH y hepatitis	48
22 Prevención combinada del VIH	49
23 Prevención de transmisión maternoinfantil	51
24 Enfermedades no transmisibles	52
25 Trauma, enfermedades crónicas y raras	54
26 Exposición a metales pesados	56
27 Infecciones asociadas a la atención	58
28 Climaterio, menopausia y salud mental	59
29 Salud bucal preventiva	61

conservan sus licencias

Referencias

[N10] OMS. mhGAP guideline, tercera edición, 2023

Documento de referencia

[N11] NICE. CG103: Delirium, recomendaciones

Documento de referencia

[N12] OMS. Palliative care

Documento de referencia

[N13] OMS. Menopause

Documento de referencia

[N14] SAMHSA. TIP 35: Enhancing Motivation for Change in Substance Use Disorder Treatment, 2019

Documento de referencia

[N21] MINSA. Contenidos temáticos oficiales SERUMS 2026-II, Psicología

Documento de referencia

[N23] OMS. Tuberculosis: infecci

Documento de referencia

Créditos de imágenes

Stages-of-change.png

Toddatkins. CC0. Sin modificaciones; esca

Fuente

Licencia y condiciones

. . Las imágene ón no implica aval de sus autores.

. . conservan sus licencias